儿童斜视围手术期管理

2025 专家共识 · 正面

术前闭环

病史/全身/视功能评估；额部标眼别/肌肉，医护麻醉三方核对。儿童以全麻为主，高危联合个体化评估。

2025 刊p501

感染与用药

严重眼表/疑眶感染治愈后择期。术前常规抗生素尚无定论；与2026指南分开。局麻总量未明确。

2025 刊p501

眼心反射阈值

心率较基线降幅<20%观察；20%~50%稳定按轻度、不稳按重度；>50%移钩暂停，由麻醉/心内处理。

2025 刊p502

重度反射升级

暂停后未恢复→增强局麻；仍无效静推阿托品0.1~0.3 mg，心率恢复正常后继续。勿外推为通用儿童急救剂量。

2025 刊p502

原文摘录；处方前核对。详见提取表与原文缺项。
100%原尺寸 · 双面长边翻转

儿童斜视围手术期管理

2025 专家共识 · 背面

术后用药/包眼

不双眼包盖，按手术情况单眼24 h；低龄避免久包。氟米龙优先替代妥布霉素地塞米松，用药1周首测压；仅非阿片镇痛。

2025 刊p502–503

术后随访

1天、1周、第1、3、6个月，后每半年；视力、屈光、眼位/运动、头位/双眼视；早期眼压/前节。

2025 刊p502

异常需警惕

嗜睡/食欲差、红肿痛警惕眼内炎；眼位异常+运动受限/扫视慢疑滑脱。避免一眼同时≥3条直肌。

2025 刊p503–504

过矫/欠矫与缺项

外斜过矫复视1~4周交替遮盖，4周仍内斜再验光；欠矫控制差6周可再手术。药物完整剂量/递减未明确。

2025 刊p501–503